



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : هبة محمد احمد على

العنوان : 9 ش عمر بن الخطاب
القاهرة

الحي / المدينة : المرج

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

رقم البطاقة : 27602200103329 رقم التليفون : 01113455761

العمر (تاريخ الميلاد) : 20-02-1976 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام رنين مغناطيسي علي الفقرات القطنية بالصبغة
قسم العلاج : الاورام
[12771]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة. تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هبة محمد احمد علي National ID: 27602200103329	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced MRI of the lumbar spine
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

MDT FORM 23 / 7 / 2025 G

Name	فيس ميس	MRN	2762200103329
Age	49/10	ID	4438124
Menopausal status	Pre.	Phone	01147573716
NRS SCORE		Marital status	Widow
BMI		Family history	-ve
CO morbidity	M -> free	REASON OF MDT	

Clinical Data

BX:	Left IDC II
ER:	818
PR:	618
HER 2:	1
Ki67:	23%

R

MDT

(17)

Sonomammography:

Mets Workup:

Pathology
IDC II 2x2cm.

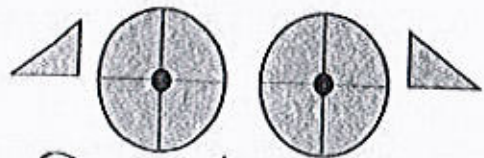
DCIS 2%.

Free deep margin

Recommendations:

Free nipple biopsy.

Free LN (0/8).



Previously TUB N3.
TNM

ypT2, ypN0.

Dr. Hasha
21/7/2025

MDT OUTCOME & PLAN

- PORT

- H.T AI / Zoladex x 2y. then

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Patient Name : **مريم محمد علي**
Patient No : **27602200103329**
Path No : **1668/24**
Sex : **Female**
Age : **48 Y**
Referring Doc :

Request No : **13000791**
Request Date : **28/11/2024**
Verification Date : **12/12/2024**
Financial Category : **أورام خارج المستشفى - مريم**
Department : **Out Patient**
Registered by : **Mrs Mayada Hegazy**

Pathology Report

Clinical Data
Left breast mass

Nature of specimen
Tru cut biopsy, collected at 27/11/2024, 10:30 am

Gross examination

Multiple(4) grayish white tissue cores up to 1.2 cm, totally submitted.
IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench
Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1F2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), &
Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination

- * Histological type: Invasive duct carcinoma
- * Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+2) Grade II
- * DCIS: No
- * Angiolymphovascular Invasion: Couldn't be detected in the received biopsy
- * Perineural Invasion: No
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 80 % tumor cells (Allred score 8/8)
- PR: Moderate nuclear reaction in 35% tumor cells (Allred score 6/8)
- HER2: No membrano reaction in of tumor cells (score 0)
- Ki 67: 25 % nuclear reaction of tumor cells

agnosis
ft breast mass, Tru cut biopsy:

Verified by :
Dr. Heba Hasan

nting Date : 16/12/2024 10:25:40

Page 1 of 2

Printing By : Mrs Mayada Hegazy



غرفة رقم (1) - دور الأول - مبنى رقم (287) - دور الأرض - مستشفى القصر العيني - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 287 - Nile Corniche - Min El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name : السيد / محمد أحمد فathy
Patient No. : 27602200103329
Path No. : 4668/24
Sex : Female
Age : 48 Y
Referring Doc :

Request No. : 13000791
Request Date : 28/11/2024
Verification Date : 12/12/2024
Financial Category : تأمين صحي - مبرور
Department : Out Patient
Registered by : Mrs Mayada Hegazy

Pathology Report

Invasive duct carcinoma, Grade II
IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 6/8).
- HER2: Negative (score 0).
- Ki67: Positive in 25% of tumor cells.

Signature
Dr. Rana Fathy
Dr. Hoba Hassan

Verified by :
Dr. Hoba Hassan

Printing Date : 16/12/2024 10:15:40

Page 2 of 2

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (982) - اورشليم قبيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 982 - Nile Corridor - Miss El Qadima - Cairo, Egypt

MRS. HEBA MOHAMED AHMED ALI
 PROF. DR. ALAA ADEL

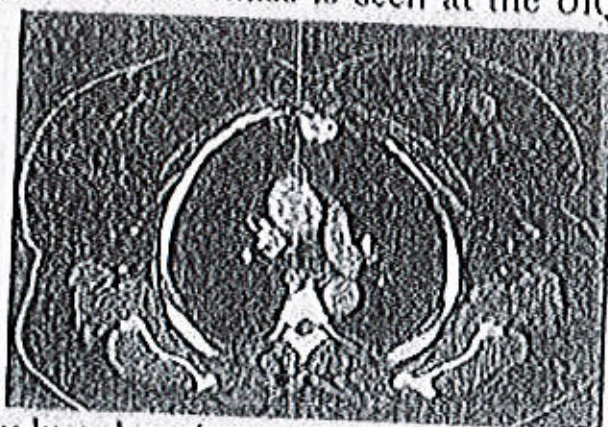
PATIENT ID: 1212488
 STUDY DATE: 24/11/2024

MULTISLICE C.T. SCAN OF THE CHEST

Multislice axial contiguous thin cuts were taken through the chest after I.V. non-ionic contrast injection.

FINDINGS:-

- Ill-defined heterogeneously enhancing soft tissue mass is seen at the UIQ of the left breast measuring 40x22mm.
- Associated overlying zones of left breast skin thickening with multiple enlarged left subpectoral and left axillary lymph nodes having rounded appearance, the largest is seen at the later level measuring 15x15mm.
- No suspicious enhancing right breast lesions on CT basis.
- No pathologically enlarged right axillary lymph nodes.
- Both lungs show normal appearance of their parenchyma and pulmonary vasculature.
- No pulmonary masses, nodules or consolidation patches.
- Normal C.T. appearance of the mediastinal structures.
- No significant mediastinal or hilar adenopathy.
- Patent tracheo bronchial tree.
- No pleural effusion seen.
- Lower cuts of the neck revealed numerous enlarged rounded left lower deep cervical/supraclavicular lymph nodes, the largest is measuring 14x12mm.



IMPRESSION:-

- No suspicious pulmonary or mediastinal lesions.
- Suspicious left breast mass with multiple enlarged left subpectoral, axillary and left supraclavicular/lower deep cervical lymph nodes, mostly metastatic.

د. محمد عبد الحليم
د. أحمد عبد الحليم
د. محمد عبد الحليم
د. أحمد عبد الحليم
د. محمد عبد الحليم
د. أحمد عبد الحليم

MRS. HEBBA MOHAMMED AHMED ALI
PROF. DR. ALAA ADEL

PATIENT ID: 1212488

STUDY DATE: 24/11/2024

MULTISLICE TRIPHASIC C.T. SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS:-

Multislice post contrast CT scan of the abdomen and pelvis with multiplanar reformatted images revealed:-

FINDINGS:-

- The liver is mildly enlarged with diffuse hypodense fatty texture and no suspicious focal lesions.
- No intra or extrahepatic biliary dilatation.
- The portal vein is patent with no thrombosis.
- Normal CT appearance of the spleen. Few small hilar splenules are noted with homogenous density and the largest is measuring 10mm.
- Normal CT appearance of the pancreas and the left suprarenal gland.
- The right suprarenal gland shows small well defined nodule measuring 10x10mm, likely adenoma.
- Both kidneys are functioning and normal.
- Retroaortic left renal vein.
- Normal filling of the urinary bladder with normal wall thickness and no calculi.
- Normal C.T appearance of the uterus with no adnexal masses.
- Normal ischiorectal fossae on both sides.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Bone window study revealed no definite lytic or suspicious sclerotic osseous lesions.

IMPRESSION:-

- No suspicious pelvlabdominal lesions.
- Mildly enlarged fatty liver with no focal lesions.

MUCH OBLIGED
ISLAM SAMEH, MD
PROF. DR. OMAR HUSSEIN
AIA

MR: Hobab Mohamed Ahmed Ali

Date: 2024/11/20

DEAR PROF.DR: Dear Sir

ID: 1212488

BILATERAL DIGITAL BREAST SONOMAMMOGRAPHY REVEALED:

- Increased skin thickening and nipple retraction could be noted on the left breast.
- Spiculated hyperdense opacity seen at the retro-areolar region.
- Normal appearance of skin and subcutaneous tissue of the right breast.
- Normal breast parenchyma that shows normal glandular to fatty distribution for patient's age.
- Right breast shows normal ultrasound appearance with no solid masses or cystic lesions.
- Complementary ultrasonography confirmed the mammographic findings.
- A large hypoechoic irregular mass is seen in the left breast at 12 o'clock about 2 cm from nipple (retro areolar) measuring collectively near 5x3 cm with speculated borders showing subtle internal vascularity with posterior acoustic shadowing.
- Two enlarged left axillary suspicious LNs are seen, the largest measures 1 x 1.9 cm with markedly thickening cortex and very small peripherally displaced hilum.

IMPRESSION: -

- Left breast mass lesion as described highly suggestive of malignant disease with suspicious left axillary LNs (BIRADS 5)
- Unremarkable right breast ultrasound. (BIRADS 1).

MUCH OBLIGED
DR. YASMINE NABIL, MD
PROF. DR. MOHAMED ABU EL-HODA
A.G.

جوسافي
رئيسة
رئيسة

9-12



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الجمهورية
مصر

09/13/2026

MDT FORM

Name:	Heba Mohamed Ahmed Ali	MRN:	573
Age:	51 Y	ID:	27602200103329
Menopausal Sta	prem	Phone:*	01113455761
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
Gender		Reason Of MDT:	
CO Morbidity:		newly developed bone mets while on adjuvant ai	
Surgical History:*	mrm	ECOG Performance Status	
		☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4	

Clinical Data:

R

L

BX:
ER: PR: HER2: KI67:

History:

premenop left breast cancer with newly developed bone mets
ct4d n2 mo ldc 2 er8/8 pr6/8 her2-ve ki 25%

rec nact 4 ac taxanes

on 5/7/2025 left mrm ypt2 ypn0/8 rec port st ai and zoladex from
8/2025, recently hip joint pain of 3 m duration

mri hip joints on 18/7/2026 left superior pubic ramus pathological process
mostly stress fracture and inflammatory process . bone scan on 29/8/2026
few scattered active metastatic lesions in left pubic bone left 8 th rib left
scapula new cts requested for mdt

Sonomammography:

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

MRI DORSOLUMBER

CTS >> PENDING RESULTS

IF NOT METASTATIC CONTINUE HORMONAL TTT

IF METASTATIC FOR RE MDT

Q1 Q2 Q3 Q4 Right Side

Q1 Q2 Q3 Q4 Left Side

Clinical Staging:

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

RADIOLOGY

PATHOLOGY

د محمد كواش

د محمد شوقي

09/13/26

(Signature)